

Síndrome Coronariana Aguda e AVC



Urgência e emergência para o internato: reconhecer cedo, priorizar risco e tratar sem perder tempo.

Aula integrada | 9º período

Dr. Igor Cruz Morais

Como me tornei louco (Prólogo)

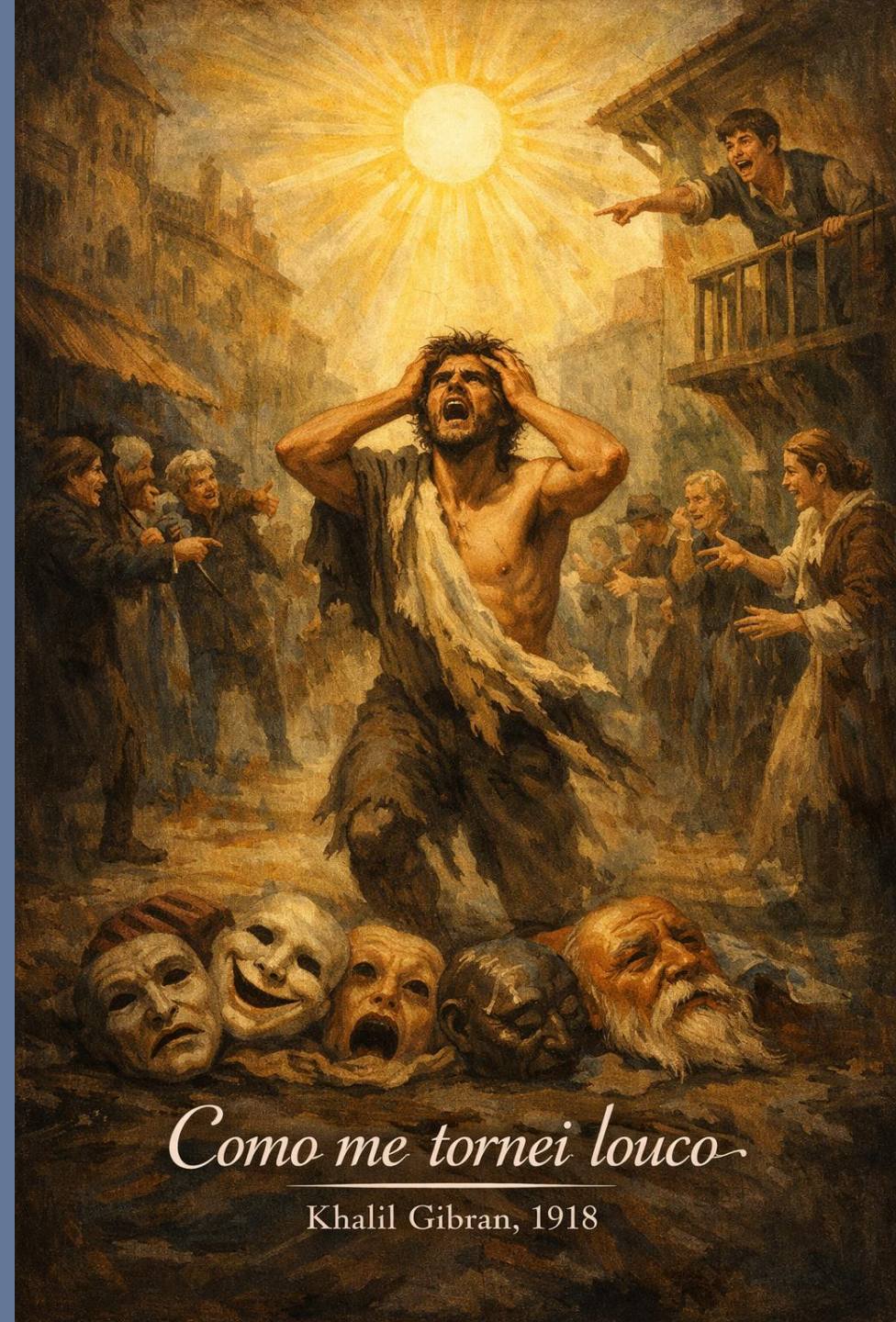
Você me pergunta como me tornei louco. Aconteceu assim: certo dia, muito antes de muitos deuses terem nascido, despertei de um sono profundo e descobri que todas as minhas máscaras haviam sido roubadas — as sete máscaras que eu mesmo havia moldado e usado em sete vidas. E corri sem máscara pelas ruas apinhadas, gritando: “Ladrões, ladrões, malditos ladrões!”

Homens e mulheres riram de mim, e alguns correram para dentro de suas casas com medo de mim.

E, quando cheguei à praça do mercado, um jovem no alto de uma casa gritou: “É um louco!” Levantei os olhos para olhá-lo; e o sol beijou meu rosto nu pela primeira vez. Pela primeira vez o sol beijava meu rosto nu, e minha alma inflamou-se de amor pelo sol; e eu já não desejava mais minhas máscaras. E, como em transe, gritei: “Benditos, benditos sejam os ladrões que roubaram minhas máscaras!”

Assim me tornei louco.

E encontrei tanto liberdade quanto segurança em minha loucura; a liberdade da solidão e a segurança de não ser compreendido, pois aqueles que nos compreendem escravizam algo em nós. Mas que eu não me orgulhe demais dessa segurança. Até um ladrão numa prisão está a salvo de outro ladrão.



Como me tornei louco

Khalil Gibran, 1918



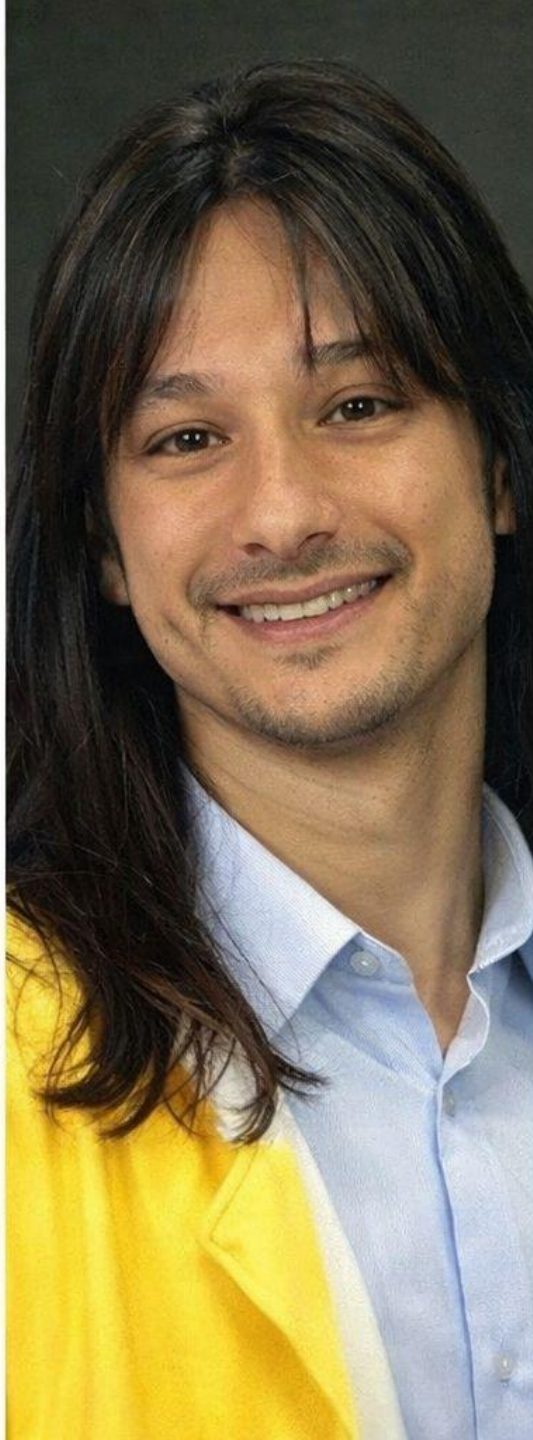
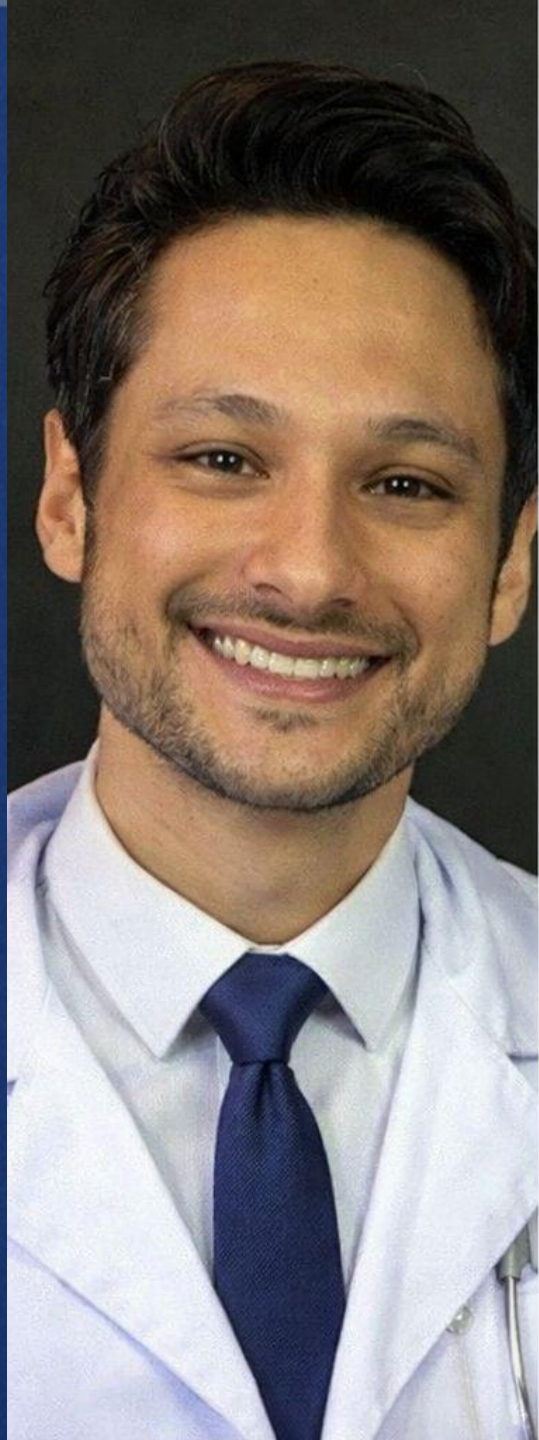
Journey

<https://youtu.be/VcjzHMhBtf0?si=xmx9fUT2K7hwzPDT>





<https://youtu.be/LatorN4P9aA?si=vu-0WrinxqhQyJ1e>





ados

TOR
ansição

Síndrome coronariana aguda

- Diferenciar dor torácica sugestiva de isquemia de diagnósticos fatais alternativos.
- Executar abordagem inicial guiada por ECG em até 10 min, troponina e risco clínico.
- Escolher estratégia de reperfusão, antiagregação, anticoagulação e monitorização.

AVC

- Ativar código AVC, aplicar NIHSS, solicitar imagem cerebral sem atraso e selecionar reperfusão.
- Reconhecer critérios práticos para trombólise IV, trombectomia e cuidados pós-reperfusão.
- Conectar fase aguda à etiologia, prevenção secundária e reabilitação precoce.

Pergunta para a turma

Se você tivesse de resumir toda a aula em duas frases, quais seriam?
Dica: uma começa com “tempo” e outra com “sistema”.

Abertura: qual erro mais mata?

Metodologia ativa – peça resposta rápida, sem consultar material

AQUECIMENTO

Pergunta para a turma

Paciente de 62 anos com dor opressiva há 40 min. Qual falha causa mais perda de oportunidade?

- A) Esperar troponina antes do ECG
- B) Dar oxigênio para todos
- C) Chamar cardiologia antes do AAS
- D) Pedir TC de tórax primeiro

Pergunta para a turma

Paciente de 74 anos com afasia súbita e hemiparesia há 55 min. Qual falha é mais grave?

- A) Fazer glicemia capilar
- B) Esperar o neurologista chegar para pedir TC
- C) Aplicar NIHSS
- D) Registrar last known well

Debrief em 1 minuto

- SCA: ECG vem antes da biomarcador-dependência; AVC: imagem e elegibilidade para reperfusão não podem esperar.

Por que esta aula importa?

Duas síndromes tempo-dependentes, alta mortalidade e enorme carga de incapacidade

EPIDEMIOLOGIA

85%

Das mortes cardiovasculares globais ocorrem por infarto e AVC.

1 em 4

Adultos tem risco ao longo da vida de sofrer AVC.

93,8 mi

Pessoas viviam com AVC no mundo em 2021.

11,9 mi

Novos AVCs no mundo em 2021.

Mensagem central

- No IAM, o atraso amplia necrose, insuficiência cardíaca e arritmias.
- No AVC, o atraso reduz chance de independência funcional e aumenta incapacidade.
- Não basta “saber conduta”: é preciso fazer o sistema funcionar sem atrito.

Curiosidades para chamar atenção

- AVC segue entre as maiores causas globais de morte e incapacidade.
- No Brasil, DAC e AVC disputam o topo da mortalidade cardiovascular conforme fonte e recorte.
- O aluno que reconhece cedo muda desfecho antes mesmo da hemodinâmica ou da trombólise.

Síndrome Coronariana Aguda



Tempo é músculo. O ECG abre a porta do raciocínio e a estratégia de reperfusão define o rumo.

Módulo 1

Dr. Igor Cruz Morais

O que chama atenção

- SCA inclui angina instável, IAM sem supra e IAM com supra.
- A forma de apresentação pode ser “dor”, pressão, aperto, queimação, dispneia ou mal-estar.
- Idosos, mulheres e diabéticos podem apresentar sintomas menos “clássicos”.

Pergunta para a turma

Pergunte à turma: qual paciente costuma “enganar” mais no pronto-socorro — o homem jovem com dor típica ou a idosa diabética com dispneia e náusea?

Mensagem prática

- Em urgência, a pergunta não é “isso é típico ou atípico?”; a pergunta é “isso pode ser isquemia coronariana e exige ECG imediato?”.
- Diretrizes atuais preferem descrever a dor como cardíaca, possivelmente cardíaca ou não cardíaca.

IAM com supra (STEMI)

- Oclusão coronária aguda com necessidade de reperfusão imediata.
- Estratégia preferencial: angioplastia primária em tempo adequado.
- Se PCI não for viável em tempo hábil, considerar fibrinólise quando elegível.

IAM sem supra / angina instável

- Troponina e estratificação de risco orientam urgência da estratégia invasiva.
- Nem todo paciente precisa cateterismo imediato; risco manda no timing.
- Angina instável persiste como diagnóstico quando há isquemia sem necrose detectável.

Da placa ao infarto

- 1 Ruptura/erosão de placa aterosclerótica.
- 2 Adesão e ativação plaquetária.
- 3 Formação de trombo e obstrução variável.
- 4 Isquemia miocárdica → necrose se o fluxo não for restabelecido.

Pérolas de raciocínio

- Angina instável e NSTEMI são primos fisiopatológicos; a troponina separa necrose detectável de isquemia sem necrose.
- Oclusão total sustentada tende a gerar STEMI, mas padrões de oclusão coronariana aguda vão além do supra “clássico”.
- Troponina elevada isoladamente não define tipo 1; é preciso contexto isquêmico.

Como a SCA se apresenta na vida real

A apresentação nem sempre é “dor torácica típica”

SCA

Sintomas sugestivos

- Pressão, aperto, peso, queimação ou desconforto retroesternal/precordial.
- Irradiação para braço, mandíbula, dorso ou epigástrio.
- Dispneia, sudorese, náusea, síncope, sensação de morte iminente.

Sinais de alerta

- Instabilidade hemodinâmica, arritmia, congestão pulmonar, dor refratária.
- ECG novo sugestivo de isquemia/oclusão coronariana.
- Troponina dinâmica com quadro clínico compatível.

Pergunta para a turma

Mini discussão: o que muda na sua suspeita quando o paciente chega sem dor, mas com dispneia súbita, sudorese e alteração isquêmica no ECG?

Dor torácica: o que você não pode perder

Nem toda dor torácica é coronária — mas algumas matam rápido

SCA

Diagnósticos fatais

- Dissecção aguda de aorta
- TEP
- Pneumotórax hipertensivo
- Tamponamento/pericardite complicada
- Ruptura esofágica

Pistas pró-SCA

- Sintoma opressivo ou equivalente isquêmico.
- Fatores de risco + história compatível.
- ECG/troponina favoráveis ao diagnóstico.

Pergunta para a turma

Erro clássico: assumir que toda dor “forte” é infarto.

Pergunta para a turma: qual detalhe da história faz você frear e pensar em aorta antes de dar antitrombótico?

Os primeiros 10 minutos definem o resto do caso

Fluxo prático de atendimento inicial

SCA

0–10 min

ABC, monitorização, acesso, AAS se elegível e ECG de 12 derivações.

10–20 min

Interpretar ECG e decidir se há STEMI/oclusão coronariana aguda.

20–60 min

Troponina, analgesia racional e acionamento da reperfusão.

1–3 h

Troponina seriada e estratégia invasiva conforme risco.

Checklist de beira-leito

- Registrar hora de início dos sintomas e tempo total de isquemia.
- Buscar contraindicações para nitrato, fibrinólise e antitrombóticos.
- Pensar em ECG seriado se a suspeita permanecer com traçado inicial não diagnóstico.

Pergunta para a turma

Erro clássico: esperar biomarcador antes do ECG. Em SCA, o relógio começa no sintoma — não no laboratório.

Achados que colocam pressão no relógio

- Supra de ST em derivações contíguas ou equivalentes de oclusão coronariana aguda.
- Infradesnível recíproco ou padrão posterior.
- Bloqueio de ramo novo com forte suspeita clínica requer contexto, não automatismo.

Quando repetir

- Dor persistente ou recorrente.
- Traçado inicial não diagnóstico com suspeita intermediária/alta.
- Mudança clínica durante observação.

Pergunta para a turma

Pergunta rápida: que parede você suspeita quando há infra em V1–V3 com onda R proeminente e clínica compatível?

Parede / derivações

- Anterior: V1–V4
- Lateral: DI, aVL, V5–V6
- Inferior: II, III, aVF
- Posterior: infra em V1–V3 / V7–V9

Pérolas

- Supra em III > II favorece coronária direita em IAM inferior.
- Suspeite infarto de VD em IAM inferior com hipotensão e campos limpos.
- ECG direito (V3R/V4R) é subutilizado e muda conduta com nitrato.

Complicações associadas

- Inferior/VD: maior risco de bradiarritmia e dependência de pré-carga.
- Anterior extenso: mais choque, IC e disfunção ventricular.
- Posterior pode ser perdido se você não procurar ativamente.

Troponina ultrassensível: ótima, mas precisa contexto

Definição universal: lesão miocárdica ≠ automaticamente IAM tipo 1

SCA

Como interpretar

- 1 Valor acima do percentil 99 = lesão miocárdica.
- 2 Elevação/queda = lesão aguda.
- 3 Para chamar IAM: precisa contexto isquêmico clínico/eletrocardiográfico/imagem.

Armadilhas

- Sepsis, taquiarritmia, IC, TEP e insuficiência renal também elevam troponina.
- Use algoritmo validado localmente do ensaio laboratorial (0/1 h ou 0/2 h quando disponível).
- O número isolado vale menos do que a curva + a história.

Tratamento inicial: o que realmente entra cedo

Nem tudo que era “mnemônico clássico” continua igual em 2026

SCA

Comece cedo

- AAS mastigado 162,5–325 mg se não houver contraindicação.
- Segundo antiagregante conforme estratégia.
- Estatina de alta intensidade durante a internação.
- Anticoagulação conforme cenário (fibrinólise, PCI ou NSTEMI-ACS).

Use com critério

- Nitrato para alívio sintomático se sem hipotensão, VD ou PDE-5 recente.
- Betabloqueador oral precoce se sem contraindicações.
- Morfina não é rotina — reserve para dor refratária e use com parcimônia.

Evite rotina sem indicação

- Oxigênio suplementar para todo mundo.
- Esperar “ver se melhora” antes de acionar reperfusão.
- Tratar dor torácica sem integrar ECG e risco.

Oxigênio, nitrato e betabloqueador: três pegadinhas clássicas

Bom protocolo evita automatismos

SCA

< 90%

Na SCA, oxigênio é indicado se houver hipoxemia, desconforto respiratório ou choque.

PA < 90

Evite nitrato em hipotensão, suspeita de VD ou uso recente de PDE-5.

< 24 h

Betabloqueador oral precoce é razoável se não houver IC aguda/choque/BAV importante.

Pergunta para a turma

Discussão rápida: por que o nitrato pode piorar justamente o infarto inferior com acometimento de ventrículo direito?

Perla de prova e de vida real

- Paciente hipotenso, jugulares ingurgitadas e pulmões limpos em IAM inferior: pense em VD, faça derivações direitas, proteja pré-carga.
- Oxigênio indiscriminado não reduz desfecho em paciente normoxêmico.

Antiagregação

- AAS para todos os elegíveis.
- PCI: prasugrel/ticagrelor geralmente preferidos, mas clopidogrel ainda tem espaço.
- Fibrinólise: clopidogrel segue muito usado; ≥ 75 anos sem dose de ataque.

Anticoagulação

- Enoxaparina ou HNF conforme estratégia e função renal.
 - Na fibrinólise, ajuste por idade e TFG é obrigatório.
- NSTE-ACS: anticoagulação é parte do cuidado
- inicial, mas não substitui invasão quando indicada.

Pergunta para a turma

Para memorizar: qual cenário faz o interno errar dose de clopidogrel e enoxaparina com mais frequência? Resposta: fibrinólise no idoso.

Reperusão: a decisão mais importante no STEMI

A via preferencial é PCI, mas o relógio manda

SCA

FMC

Reconhecer STEMI/OCA, interpretar ECG e ativar a rede.

≤ 90 min

Meta prática de PCI primária no centro capaz.

≤ 120 min

Se PCI não é viável desde o 1º contato, considerar fibrinólise.

Pós-lise

Reavaliar sucesso e programar estratégia invasiva.

Tradução para o plantão

- PCI primária é o padrão quando disponível em tempo adequado.
- Fibrinólise não é “segunda classe”: salva tempo e miocárdio quando a PCI oportuna não existe.
- Porta-agulha ≤30 min e metas de reperusão da rede devem ser perseguidas ativamente.

Quando considerar

- STEMI/oclusão coronariana aguda dentro da janela e sem acesso oportuno à PCI.
- Maior benefício quanto mais cedo após o início dos sintomas.
- Sempre excluir contraindicações absolutas ao fibrinolítico.

Alteplase no IAM

- 15 mg IV em bolus.
- 0,75 mg/kg em 30 min (máx. 50 mg).
- Depois 0,5 mg/kg em 60 min (máx. 35 mg).
- Dose total máxima: 100 mg.

Pergunta para a turma

Pergunta prática: por que muitos serviços preferem tenecteplase quando disponível na rede?
Resposta esperada: bolo único, logística mais simples.

NSTEMI/angina instável: risco define urgência

Troponina positiva não é o único marcador de gravidade

SCA

Estratifique

- GRACE para prognóstico e apoio à estratégia invasiva.
- TIMI como ferramenta simples complementar.
- HEART é útil na dor torácica do PS, mas não substitui o diagnóstico de ACS estabelecida.

Sinais de alto risco

- Instabilidade hemodinâmica ou elétrica.
- Dor refratária, IC aguda, alterações dinâmicas extensas de ST/T.
- Troponina significativa em contexto compatível.

Pergunta para a turma

Atividade relâmpago: qual score você usaria no corredor do PS para dor torácica ainda não definida? E qual score pesa mais para estratégia invasiva em NSTEMI-ACS?

Complicações que mudam o plantão

Toda SCA grave é potencialmente elétrica, mecânica e hemodinâmica

SCA

Elétricas

- FV/TV
- BAV e bradicardia no IAM inferior
- FA e outras taquiarritmias

Hemodinâmicas

- Choque cardiogênico
- Edema agudo de pulmão
- Hipotensão por acometimento de VD

Mecânicas

- Insuficiência mitral aguda
- Comunicação interventricular
- Ruptura de parede livre

Caso clínico 1 – SCA

Metodologia ativa: conduza a discussão em 4 etapas

CASO

Cenário

- Homem, 58 anos, tabagista, dor opressiva retroesternal há 50 min, sudorese intensa.
- PA 96/60, FC 54, SpO₂ 95%, pulmões limpos, jugulares discretamente ingurgitadas.
- ECG: supra em II, III e aVF.

Pergunta para a turma

Etapa 1

O que você faz nos primeiros 5 minutos?

Etapa 2

Que exame adicional simples pode mudar sua segurança com nitrato?

Etapa 3

Qual território/artéria é mais provável?

Etapa 4

Se o serviço não tem hemodinâmica, como você pensa a rede?

1. Reconheça

1 Dor/desconforto ou equivalente isquêmico.

2 ECG em até 10 min.

3 Troponina com contexto.

2. Priorize

1 STEMI/OCA = reperfusão urgente.

2 NSTEMI = risco define timing.

3 Pense nos diagnósticos diferenciais fatais.

3. Trate

1 AAS + antitrombótico correto.

2 PCI quando possível em tempo.

3 Evite automatismos sem indicação.

Acidente Vascular Cerebral



Tempo é cérebro. Detectar, direcionar e reperfundir cedo muda independência funcional.

Módulo 2

Dr. Igor Cruz Morais

3ª

Em 2021, o AVC foi a 3ª causa global combinada de morte e incapacidade.

87%

Das mortes por AVC ocorrem em países de baixa e média renda.

1 em 4

Adultos terão AVC ao longo da vida.

84%

Cerca de 84% dos AVCs são isquêmicos em séries brasileiras citadas em protocolos.

Por que isso importa ao internato?

- A janela terapêutica é curta, mas o reconhecimento depende de atitudes simples: hora exata, glicemia, NIHSS, imagem e fluxo da rede.
- Mesmo quando a fase hiperaguda já passou, o internato ainda influencia unidade de AVC, disfagia, prevenção de complicações, etiologia e reabilitação.

Definição e subtipos de AVC

Para o plantão, pense em síndrome neurológica focal súbita de provável causa vascular

AVC

AVC isquêmico

- Bloqueio súbito do fluxo sanguíneo cerebral.
- É o subtipo mais frequente.
- Pode ter núcleo irreversível e penumbra potencialmente recuperável.

AVC hemorrágico

- Sangramento intracraniano espontâneo ou subaracnoide.
- Menos frequente, porém com maior letalidade inicial.
- Exige outro raciocínio de pressão, reversão e neurocirurgia.

FAST

- Face: desvio facial
- Arm: queda do braço
- Speech: fala alterada
- Time: cada minuto conta

BE-FAST

- Acrescenta Balance e Eyes.
- Ajuda a lembrar AVCs de circulação posterior.
- Boa ferramenta educativa para leigos e equipes.

Pergunta para a turma

Ponto didático: FAST é triagem; NIHSS é avaliação intra-hospitalar. Não troque o papel das ferramentas.

8 Ds

- Detection (detecção)
- Dispatch (acionamento/comunicação)
- Delivery (transporte)
- Door (porta adequada)
- Data (dados clínicos e last known well)
- Decision (decisão)
- Drug (trombólise)
- Disposition (encaminhamento e continuidade)

Pergunta para a turma

Peça para um aluno mapear em voz alta onde seu hospital mais falha hoje: detecção, imagem, decisão ou disposição?

Chegada

ABC, glicemia, NIHSS e last known well.

≤ 20 min

TC/RM inicial.

≤ 45 min

Interpretação e decisão.

≤ 60 min

Porta-agulha para trombólise IV.

Nunca esquecer

- Registrar anticoagulante em uso, cirurgia recente, sangramento, PA e glicemia.
- Imagem inicial serve sobretudo para excluir hemorragia e selecionar reperfusão.
- Se houver suspeita de grande vaso, angio-TC/angio-RM deve entrar cedo.

Para que serve?

- Quantifica gravidade inicial.
- Facilita comunicação do caso.
- Ajuda em seleção e seguimento.

Componentes centrais

- Consciência e comandos
- Olhar, campos visuais, face
- Braços, pernas, sensibilidade
- Linguagem, disartria e negligência

Pergunta para a turma

Dica de ensino: em vez de “aprender NIHSS por decoreba”, peça aos alunos que localizem o déficit e expliquem por que cada item existe.

Itens 1–6

- 1a–c: nível de consciência, perguntas e comandos.
- 2: melhor olhar conjugado.
- 3: campos visuais.
- 4: paralisia facial.
- 5a–5b: braço esquerdo e direito.
- 6a–6b: perna esquerda e direita.

Itens 7–11

- 7: ataxia de membros.
- 8: sensibilidade.
- 9: linguagem.
- 10: disartria.
- 11: negligência/extinção.
- Leitura prática: 1–4 leve, 5–15 moderado, >15 grave (classificação didática).

Imagem no AVC: qual exame responde qual pergunta?

TC sem contraste é a porta; RM-DWI é a lupa mais sensível para isquemia aguda

AVC

TC sem contraste

- Exame inicial mais disponível.
- Exclui hemorragia rapidamente.
- Pode ser normal nas primeiras horas do AVC isquêmico.

RM com difusão

- Mais sensível para isquemia hiperaguda.
- Útil quando a TC não esclarece e a suspeita clínica persiste.
- Nem sempre é o exame mais rápido da rede.

Angio-TC / perfusão

- Seleção de oclusão de grande vaso.
- Ajuda em trombectomia e mismatch quando aplicável.

ASPECTS e mRS: dois escores que todo interno deve respeitar

Um ajuda na imagem aguda; o outro fala a língua do desfecho funcional

AVC

ASPECTS

- Escala tomográfica da circulação anterior.
- Vai de 10 (sem sinais precoces) a 0 (extenso acometimento).
- Ajuda na seleção e na comunicação do volume de lesão precoce.

mRS – modified Rankin Scale

- 0 = sem sintomas; 6 = óbito.
- É a escala funcional clássica para desfecho em AVC.
- Pense nela quando discutir prognóstico e reabilitação.

Pense em elegibilidade

- Déficit neurológico incapacitante.
- Imagem sem hemorragia.
- Janela e critérios clínicos/laboratoriais adequados.

Antes de liberar

- PA, glicemia, anticoagulante em uso, cirurgia recente, sangramento.
- Peso estimado e hora do último momento bem.
- Consentimento e logística preparados.

Pergunta para a turma

Pergunta crítica: quando a TC inicial está “normal”, isso exclui AVC isquêmico hiperagudo? Não. Ela pode ser normal cedo e ainda assim o paciente ser elegível.

Alteplase no AVC – dose que precisa sair automática

Aqui a dose não é a do IAM

AVC

0,9 mg/kg

Dose total IV para AVC isquêmico agudo.

10%

Da dose total em bolus IV em 1 minuto.

90%

Em infusão contínua ao longo de 60 minutos.

90 mg

Dose máxima.

Pós-trombólise: três regras de ouro

- Monitorar PA e exame neurológico com vigilância estreita.
- Não usar AAS, outro antiagregante ou anticoagulante nas primeiras 24 h.
- Repetir imagem em 24 h antes de introduzir antitrombóticos.

Tenecteplase

- A diretriz 2026 reforça que há espaço crescente para tenecteplase em cenários selecionados.
- Tem vantagem logística por administração em bolo.
- A escolha depende do protocolo institucional e da rede.

Trombectomia mecânica

- Pense cedo quando houver oclusão de grande vaso e perfil favorável.
- Imagem vascular e seleção adequada são decisivas.
- Em muitos pacientes, o benefício funcional supera em muito qualquer outra medida isolada da fase aguda.

> 94%

Meta prática de saturação no AVC; não ofertar O₂ de rotina se normoxêmico.

Glicemia

Hipoglicemia e hiperglicemia atrapalham diagnóstico e prognóstico.

PA

Controle pressórico depende de trombólise/trombectomia.

Temp.

Trate febre; o cérebro tolera mal hipertermia.

Checklist de suporte

- Screening de disfagia antes de VO.
- Profilaxia de TVP, preferindo abordagem mecânica em muitos pacientes imóveis; antitrombótico conforme contexto hemorrágico.
- Unidade de AVC, mobilização e reabilitação precoce quando estável.

Classificação TOAST

- 1. Aterosclerose de grandes artérias
- 2. Cardioembólico
- 3. Oclusão de pequenos vasos (lacunar)
- 4. Outras etiologias determinadas
- 5. Etiologia indeterminada/criptogênica

Pergunta para a turma

Discussão: qual subtipo costuma chegar mais grave e com pior prognóstico inicial? Resposta esperada: cardioembólico.

Prevenção secundária: onde a etiologia encontra o tratamento

O caso não termina quando a janela de reperfusão fecha

AVC

Em todos

- Controle de PA, glicemia, tabagismo e estilo de vida.
- Estatina de alta intensidade quando apropriada.
- Planejamento de reabilitação e educação do paciente.

Se aterotrombótico

- Antiagregação, estatina, controle agressivo de fatores de risco.
- Estudo de vasos cervicais/intracranianos orienta conduta.

Se cardioembólico

- Rastrear FA e outras fontes embólicas.
- Anticoagulação entra no momento correto, não na correria da hiperaguda.

E quando é hemorrágico?

Mude o chip: sair da reperfusão e entrar em contenção de dano

AVC

Prioridades no AVC hemorrágico

- Reconhecer e quantificar o sangramento na imagem.
- Controlar PA conforme protocolo, corrigir coagulopatia e anticoagulantes.
- Acionar neurocirurgia/unidade especializada quando indicado.

Pergunta para a turma

Regra de ouro: ICH Score é útil para gravidade, mas não deve ser usado isoladamente para limitar cuidado.

Mensagem didática

- AVC hemorrágico é menos frequente que o isquêmico, porém mais letal na fase inicial.
- A mortalidade individual tende a ser maior; a carga absoluta de incapacidade populacional do isquêmico segue enorme por sua frequência.

Por que falar disso em urgência?

- Porque decisões das primeiras 24–72 h influenciam deglutição, mobilidade, delirium, pneumonia e dependência.
- Unidade de AVC e reabilitação precoce reduzem complicações e melhoram funcionalidade.

Conexão com o hospital de transição

- O caso agudo não termina na porta da UTI ou do PS.
- Transição segura e programa estruturado de reabilitação mudam reinternação, funcionalidade e qualidade de vida.
- Para o aluno: sempre pense no “dia seguinte” do AVC.

Cenário

- Mulher, 72 anos, afasia súbita e hemiparesia direita há 70 min.
- Glicemia 116 mg/dL, PA 178/96, SpO₂ 96%, NIHSS 11.
- TC sem contraste sem hemorragia.

Debrief esperado

- Last known well, NIHSS, imagem, elegibilidade e vigilância pós-tPA.
- AAS e anticoagulantes não entram nas primeiras 24 h após alteplase.

Pergunta para a turma

Etapa 1

Que dado temporal você precisa registrar sem falha?

Etapa 2

Ela pode receber trombólise IV?

Etapa 3

O que mais você pede cedo se suspeitar de grande vaso?

Etapa 4

Quando entra AAS se ela for trombolisada?

O que é igual

- Síndrome tempo-dependente.
- Ativação precoce de protocolo.
- Valor enorme de sistemas organizados e pré-notificação.
- Erro de atraso custa tecido e função.

O que muda

- SCA: ECG e reperfusão coronária.
- AVC: neuroimagem, NIHSS e seleção neurovascular.
- Oxigênio: corte prático mais baixo na SCA; no AVC, manter >94%.

Ponto pedagógico

- O melhor interno não é o que decora dose: é o que não perde tempo e não erra prioridade.
- Protocolo não substitui clínica; ele organiza a clínica.

SCA

- “Dor atípica exclui infarto.” → Falso.
- “Oxigênio melhora todo IAM.” → Falso.
- “Troponina normal inicial exclui NSTEMI.” → Falso.

AVC

- “TC normal inicial exclui AVCi.” → Falso.
- “FAST basta dentro do hospital.” → Falso.
- “Todo déficit leve pode ser ignorado.” → Falso.

Pergunta para a turma

Feche este slide pedindo: qual desses mitos você mais ouviu em estágio ou plantão?

Quiz rápido – 5 perguntas para consolidar

Use como votação oral ou QR de enquete

QUIZ

Perguntas

- 1. Qual exame deve ser feito em até 10 min na suspeita de SCA?
- 2. Qual a meta de porta-agulha na trombólise do AVC?
- 3. Em qual situação o nitrato pode piorar o quadro no IAM?
- 4. Quando iniciar AAS após alteplase no AVC?
- 5. Qual classificação etiológica do AVC isquêmico usa os grupos cardioembólico, grandes vasos e pequenos vasos?

SCA no PS

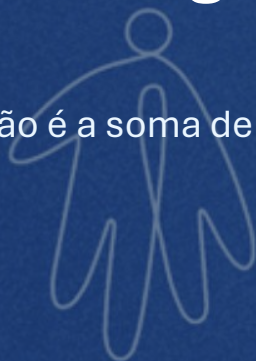
- 1 Suspeitou → ECG em até 10 min + AAS se elegível + monitorização.
- 2 STEMI/OCA → ativar reperfusão; PCI preferencial se em tempo adequado.
- 3 Sem supra → troponina seriada + risco (GRACE/TIMI/HEART conforme contexto).
- 4 Oxigênio só se hipoxemia; nitrato e betabloqueador com indicação e sem contraindicação.
- 5 Estatina alta intensidade e antitrombótico correto cedo.

AVC no PS

- 1 Déficit focal súbito → glicemia + last known well + NIHSS + ativar código AVC.
- 2 TC sem contraste rápida; se necessário, angio-TC/angio-RM para grande vaso.
- 3 Se elegível → trombólise IV; se grande vaso e perfil favorável → trombectomia.
- 4 Pós-alteplase: sem antitrombótico nas primeiras 24 h e repetir imagem antes de introduzir.
- 5 Unidade de AVC, disfagia, profilaxia de complicações, etiologia e reabilitação.

Take-home message

A urgência bem feita não é a soma de remédios: é a soma de reconhecimento, prioridade, sistema e timing.



REDE PAULO
DE TARSO
cuidados continuados integrados

SCA: ECG cedo, risco cedo, reperfusão cedo.

AVC: código cedo, imagem cedo, seleção cedo, reabilitação cedo.



PAULO DE TARSO
clínica de transição



SUNTOR
clínica de transição

Fechamento

Dr. Igor Cruz Morais

Referências centrais

- 2025 ACC/AHA/ACEP/NAEMSP/SCAI Guideline for the Management of Patients With Acute Coronary Syndromes
- 2023 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes
- Diretriz Brasileira de Atendimento à Dor Torácica na Unidade de Emergência – 2025
- Linha de Cuidado do IAM e Protocolo de Síndromes Coronarianas Agudas – Ministério da Saúde
- Fourth Universal Definition of Myocardial Infarction (2018)
- 2021 AHA/ACC Chest Pain Guideline
- WHO Cardiovascular diseases fact sheet (updated 2025)
- Estatística Cardiovascular – Brasil 2023 (SBC/ABC)

Referências centrais

- 2026 AHA/ASA Guideline for the Early Management of Patients With Acute Ischemic Stroke
- AHA/ASA 2022 Guideline for Spontaneous Intracerebral Hemorrhage
- PCDT do Acidente Vascular Cerebral Isquêmico Agudo – Ministério da Saúde (2025)
- WHO Stroke Fact Sheet (updated 2025)
- ESO/ESMINT guidance on reperfusion strategies
- WHO neurological/stroke updates 2025–2026
- Ministério da Saúde – Linha de cuidado e protocolos de AVC
- Escalas clínicas: NIHSS, mRS, ASPECTS e TOAST

Obrigado!

Discussão • dúvidas • aplicação prática no plantão



REDE PAULO
DE TARSO
cuidados continuados integrados



PAULO DE TARSO
clínica de transição



SUNTOR
clínica de transição